

INDICADO POR: Dr. Keffel

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

OSSIMAR ALVES

IDADE: 68 PESO: 116 ALTURA: 190 PROFISSÃO: Aposentado

SINTOMAS: Sonolência diurna / edema mmb (edema no calor)

QUEIXAS: esposa reclama do ronco

MEDICAMENTOS: Bravant 170mg / Sclorok (12.5mg) / metilcobalina

HAS extra rinite / B12

MÉDICO:

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 5x academia

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19h)

HORA QUE DORME: 23 - 24 HORA QUE ACORDA: 8h

COCHILHO (☒) S () N 1:30 DORME ACOMPANHADO: (☒) S () N () EVENTUALMENTE esposa roncaTEM FILHOS: (☒) S () N 2 / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: (☒) S () X NA SEMANA () N 6x e sábadoFUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Desvio septo (D) / miopatia

CIRURGIAS: (☒) N NASAL (☒) S AMIGDALECTOMIA 4 10 anos

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (☒) N RESPIRATÓRIA (☒) N ENDÓCRINA (☒) S CARDÍACA(☒) N ORTOPÉDICA (☒) N NEUROLÓGICA () OUTROS:POLISSONOGRAMA COM CPAP: (☒) S () N SPO2 C/ CPAP: 86% PRESSÃO NO EXAME: 7cmH₂O

07/11/25 Avaliação

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: OSSIMAR ALVES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 18-09-2025

Idade: 68 anos

Peso: 116 kg

Altura: 1,90 m

Médico Solicitante: DR. KEFFEL ANTONIO FERNANDES
PEREIRA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 18/09/2025 22:19 e finalizado às 19/09/2025 05:40.

A latência para início do sono foi de **10,0 min** e a latência para o sono REM de **203,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 316,0 min, com eficiência do sono de **71,8 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,3 %** de estágio N1, **53,8 %** de estágio N2, **19,3 %** de estágio N3 e **23,6 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 114,0 min. Ocorreram 43 despertares, sendo o índice de **5,9 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **4,6 (nº/h)**, O associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 34, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 34 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **6,5 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 4,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 7,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 6,5 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 6,5 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 92%, a média de 91% e a mínima de 86%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 4,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 4,8 (nº/h) e em NREM foi de 7,0 (nº/h). Permaneceu 2,5 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório leve (**6,5 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**86%**);
3. Latência para o início do sono normal (**10,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**203,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**71,8 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**5,9 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**3,3 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**53,8 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**19,3 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**23,6 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco intenso, constante verificado via sensor de ronco;
12. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **4,6 (n°/h)**;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

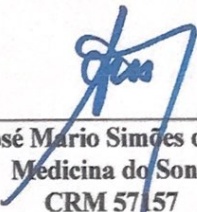
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 7,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: OSSIMAR ALVES
ID: 0
Altura: 1,90 m
Peso: 116 kg
Sexo: Masculino
Data de Nascimento: 6-8-1957
IMC: 32,13

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:19:55
Data do Exame: 18-09-2025
Médico Solicitante: DR. KEFFEL ANTONIO FERNANDES PEREIRA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	18/09/2025 22:19
Data/Horário de Término:	19/09/2025 05:40
Tempo Total de Registro (TTR):	440,0
Tempo Total de Sono (TTS):	316,0
Latência para o início do sono:	10,0
Latência para o sono REM:	203,0
Tempo acordado após o adormecer:	114,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	71,8 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	10,5	170,0	61,0	74,5	124,0
% de TTS	3,3	53,8	19,3	23,6	28,2

Parâmetros de normalidade recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (versão 3.0/2022)

	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	71,8 %	≥85%
Latência para o início do sono	10,0 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	203,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	3,3 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	53,8 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	19,3 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	23,6 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	28,2 %	5%
Índice de despertares	5,9 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	6,5 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h



Sleep Study Report

Nome do Paciente: Ossimar Alves
Nome do Médico: Eduardo R.B.Costa
Data do Exame: 19/08/2025

Prezado Ossimar Alves,

Agradecemos por ter se submetido a polissonografia de noite inteira. Agora vamos apresentar abaixo os dados obtidos do seu exame.

Seu tempo total de estudo (que é calculado do horário que você ligou o equipamento até você retirá-lo do braço) foi de 7 hrs, 46 min. Mas como estamos avaliando para Apnéia Obstrutiva do Sono estamos interessados no tempo que você ficou dormindo. Seu tempo total de sono foi de 6 hrs, 16 min. Em média, uma pessoa com hábitos de sono normais dorme de 6 a 8 horas por noite.

Observando seus dados do sono podemos obter algumas informações importantes:

Seu Índice de Apnéia/Hipopnéia (abreviado como AHI—apnea/hypopnea index) foi de 41,1. Esse valor é o número médio de eventos de apnéia e hipopnéia por hora de sono durante a noite. Evento de apnéia é um episódio de oclusão total da respiração por mais de 10 segundos, e um evento de hipopnéia é um episódio de oclusão parcial. O valor normal do AHI é de 5 ou menos.

O seu Índice de Distúrbio Respiratório (RDI) foi de 42,0. Esse valor é calculado de uma forma muito similar ao AHI mas adicionando um tipo de evento respiratório chamado RERA que também é contado. O RERA é a abreviação de Respiratory Effort Related Arousal – Despertares Relacionados ao Esforço Respiratório – que é essencialmente um pequeno despertar de poucos segundos em seguida de uma oclusão parcial das vias aéreas. O valor normal do RDI é também de 5 ou menos.

O seu Índice de Desaturação de Oxigênio (ODI) foi de 27,7. O Esse valor é o número médio de vezes que o Oxigênio no seu sangue cai 4% ou mais durante uma hora de sono. Como pode imaginar, quanto mais o Oxigênio cai mais forte o coração tem que trabalhar. O valor normal do ODI é 5 ou menor.

Analisando seu estágio de sono REM (Rapid Eye Movement – movimento rápido dos olhos) verificamos que você esteve nesse estágio 15,6% do seu tempo de sono. O Sono REM é muito importante porque durante esse estágio seu corpo está sendo reabastecido e nutrido. O valor normal para o REM é entre 15 e 30% dependendo de outras condições. Também acredita-se que é durante o estágio REM que sonhamos.

Se precisar de mais esclarecimentos, estaremos à disposição.

Atenciosamente,


Dra. Andreza Chagu
Cardiologista
CRM 196.831